

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬
DNA合成・細胞分裂を障害

白金製剤 シスプラチン カルボプラチン

代謝拮抗薬・微小管阻害薬 ペメトレキセド ゲムシタビン S-1 パクリタキセル nab-パクリタキセル ドセタキセル

トポ阻害薬(小細胞) エトポシド イリノテカン アムルピシン

EGFR・ALK阻害薬

頻度の高いドライバー遺伝子を標的

EGFR阻害薬 ゲフィチニブ エルロチニブ アファチニブ ダコミチニブ オシメルチニブ ラゼルチニブ

アミバンタマブ

ALK・ROS1阻害薬 アレクチニブ プリグチニブ ロルラチニブ クリゾチニブ エヌトレクチニブ

その他の標的薬

希少ドライバー遺伝子・血管新生

BRAF・MET・RET・KRAS ダブラフェニブ テボチニブ カブマチニブ セルベルカチニブ ソトラシブ

HER2変異(ADC) T-DXd 血管新生阻害薬 ベバシズマブ ラムシルマブ

免疫チェックポイント阻害薬

T細胞のブレーキを解除

抗PD-1抗体 ニボルマブ ペムブロリズマブ セミプリマブ 抗PD-L1抗体 アテゾリズマブ デュルバルマブ

抗CTLA-4抗体 イピリムマブ トレメリムマブ

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い)
 ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(進行・再発)

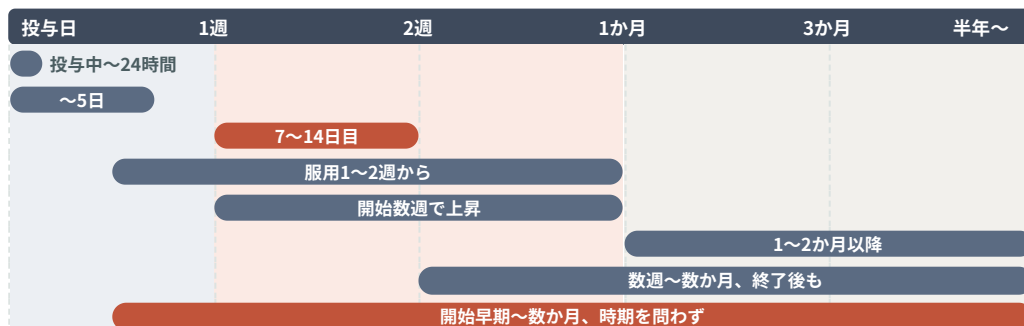
対象	1次治療 薬局の出番	2次治療	3次治療以降
EGFR変異陽性	● オシメルチニブ(±プラチナ併用化学療法) ● 他のEGFR阻害薬	● プラチナ併用化学療法(±ベバシズマブ)	● ドセタキセル±ラムシルマブ等
ALK融合遺伝子	● アレクチニブ ● ロルラチニブ ● プリグチニブ	● 未使用のALK阻害薬(ロルラチニブ等)	● プラチナ併用化学療法等
ドライバー陰性 PD-L1 50%以上	● 免疫チェックポイント阻害薬単剤、または化学療法との併用	● プラチナ併用化学療法	● ドセタキセル±ラムシルマブ等
ドライバー陰性 PD-L1 50%未満	● プラチナ併用化学療法+免疫チェックポイント阻害薬(±抗CTLA-4抗体)	● ドセタキセル±ラムシルマブ	● S-1 ● ペメトレキセド(非扁平上皮)等
小細胞肺癌 進展型	● カルボプラチン+エトポシド+アテゾリズマブ/デュルバルマブ	● アムルピシン ● ノギテカン等	● 全身状態に応じて選択

☒ 細胞障害性抗がん薬中心
 ☒ 分子標的薬(注射)を含む
 ☒ 経口薬を含む
 ☒ 免疫チェックポイント阻害薬

ROS1・BRAF・MET・RET・KRAS G12C・HER2変異は、それぞれ対応する標的薬を1次または2次治療で使用。局所進行期は化学放射線療法後にデュルバルマブで地固め療法を行う。

3 副作用の特徴と発現時期

- インフュージョンリアクション
- 悪心・嘔吐(シスプラチン)
- 好中球減少(化学療法)
- 皮疹・下痢(EGFR阻害薬)
- 脂質異常症(ロルラチニブ)
- 爪囲炎(EGFR阻害薬)
- irAE(甲状腺・肝・大腸炎等)
- 間質性肺疾患


☒ 重篤・特に注意
 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. 非小細胞肺癌はドライバー遺伝子とPD-L1で1次治療が決まる「個別化医療」の代表
2. 同じEGFR・ALK阻害薬でも世代で副作用が異なる(アファチニブ=皮膚・下痢、ロルラチニブ=脂質・中枢神経)
3. ILD(咳・息切れ・発熱)はTKI・ICI・ADCに共通。薬局の聞き取りと病院の早期対応で守る